NEXO INTELIGÊNCIA CLÍNICA / LEITURAS PARA CONECTAR IDEIAS

Psicologia em Pauta

EDIÇÃO 06

TRABALHO, POLÍTICAS PÚBLICAS E TERCEIRO SETOR

Quem cuida de quem cuida?

Psicologia, SUS, SUAS e terceiro setor: identidade profissional, financiamento e condições de trabalho em São Paulo

Texto e curadoria de
Gabriel Alves Batista

NESTA EDIÇÃO

Um editorial crítico, mas verificável

Psicologia é saúde e compreende o humano em contexto

PIA e PTS: instrumentos distintos, competências em diálogo

Edição digital em A4 • Texto selecionável • Referências e links

Uma leitura educativa para ampliar perguntas e possibilidades.

GUIA DA EDIÇÃO

Entre ideias, histórias e perguntas.

Artigo de opinião e reportagem documental sobre Psicologia, financiamento e saúde das equipes no SUS, SUAS e terceiro setor, com evidências e limites de interpretação.

Um editorial crítico, mas verificável . . . 3
Psicologia é saúde e compreende o humano em contexto . . . 4
PIA e PTS: instrumentos distintos, competências em diálogo . . . 5
A política pública acontece onde as pessoas estão . . . 7
São Paulo em números: uma rede fortemente parceirizada . . . 7
O repasse não chega ao trabalhador em linha reta . . . 9
Saúde e assistência: como ler diferenças de escala . . . 10
O que a pesquisa encontra sobre condições de trabalho . . . 11
Assédio, prevenção e saúde de quem cuida . . . 12
Salário, jornada e proteção: distinguir proposta e direito . . . 13
Quando o setor de origem apaga competências . . . 14
Dez mudanças possíveis para qualificar serviços e proteger equipes . . . 15
O que a edição consegue sustentar e até onde . . . 16
Quem cuida de quem cuida? . . . 17
Nota editorial, ética e recorte documental . . . 18
Referências da edição. . . . 19

Continuar a leitura no navegador

A leitura e os exercícios têm finalidade educativa. Exemplos e perguntas ajudam a observar contextos e não substituem avaliação individual.

CAPÍTULO 01

Um editorial crítico, mas verificável

Psicologia, SUS, SUAS e terceiro setor: identidade profissional, financiamento, precarização e caminhos para qualificar o cuidado em São Paulo.

O crachá muda. A política pública muda. A finalidade institucional muda. A Psicologia não desaparece.

Gabriel Batista - texto da edição original

Se uma política pública existe para proteger pessoas, a precarização de quem realiza esse cuidado pode ser tratada como simples problema administrativo?

Este documento combina linguagem jornalística, apreciação crítica e revisão documental. Seu objetivo não é produzir uma auditoria de uma organização específica, nem afirmar que toda parceria com o terceiro setor resulte em precarização. A pergunta é estrutural: quais condições de financiamento, gestão do trabalho, reconhecimento profissional e proteção psicossocial ajudam ou atrapalham a qualidade do cuidado prestado por psicólogas e psicólogos nas políticas públicas?

A edição de origem adota margens acadêmicas, sistema autor-data e referências organizadas em padrão ABNT, preservando uma diagramação editorial para facilitar a leitura. Segundo a metodologia declarada naquele documento, dados municipais foram confrontados com normas de São Paulo e argumentos sobre trabalho e saúde foram apoiados por documentos do Conselho Federal de Psicologia e por estudos revisados por pares. Essa descrição registra o procedimento informado na edição original; a conferência das fontes desta adaptação está identificada caso a caso.

- Explicar por que a Psicologia permanece uma profissão técnica, inclusive quando atua no SUAS e em OSCs.
- Mostrar como a rede socioassistencial paulistana depende de parcerias com OSCs e como o financiamento alcança o item recursos humanos.
- Documentar, com limites metodológicos explícitos, evidências sobre precarização, assédio, insegurança laboral e saúde mental dos trabalhadores do SUAS.
- Propor critérios de qualidade para poder público, OSCs, lideranças, recrutadores e para a própria categoria profissional.

> Comparar orçamentos do SUS e do SUAS ajuda a visualizar escala, mas não demonstra, sozinho, “maior valorização” de uma política. Saúde inclui hospitais, medicamentos, exames, urgência e infraestrutura de alto custo. Nesta edição, a comparação é tratada como contexto, não como causalidade.

Fatos documentais aparecem acompanhados de fonte e data. Inferências são apresentadas como leitura crítica. Propostas aparecem em seções próprias. Quando um estudo tem amostra pequena, município específico ou dados antigos, isso é indicado. Essa separação é deliberada: crítica política ganha força quando não precisa exagerar a evidência.

> A edição de origem tem corte documental de 26 de agosto de 2026. Esta adaptação recebeu conferência de fontes em 17 de outubro de 2026; números municipais preservam o período informado nas respectivas publicações. Conferência documental não equivale à aprovação editorial ou clínica da adaptação.

CAPÍTULO 02

Psicologia é saúde e compreende o humano em contexto

A Resolução nº 287/1998 do Conselho Nacional de Saúde relaciona a Psicologia entre as categorias profissionais de saúde de nível superior (BRASIL, 1998). Isso é relevante para corrigir uma distorção frequente no mercado: a experiência de um psicólogo no SUAS não deixa de ser experiência psicológica apenas porque ocorreu fora de um equipamento sanitário.

Ao mesmo tempo, a atuação no SUAS não autoriza transformar assistência social em consultório. O foco institucional é a proteção social, a garantia de direitos, a autonomia, os vínculos, o território e o enfrentamento das vulnerabilidades. O ponto crítico está entre dois excessos: “clinificar” o social ou, no extremo contrário, reduzir o psicólogo a um técnico genérico de nível superior.

> Interdisciplinaridade não é indiferenciação. Profissões diferentes precisam colaborar sem apagar seus núcleos de formação, seus limites éticos e as competências específicas que justificam a presença de cada uma na equipe.

O relatório da III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS documenta debates sobre reconhecimento da profissão, formação, condições de trabalho e educação permanente. É um registro de evento e de relatos de participantes, não um levantamento representativo de todos os profissionais do SUAS (CFP, 2025).

Esse diagnóstico não deve alimentar uma disputa corporativa com o Serviço Social. A questão é outra: uma equipe multiprofissional só é verdadeiramente interdisciplinar quando consegue somar perspectivas sem transformar todas as formações em uma mesma função indistinta.

O melhor recrutamento não pergunta apenas "onde você trabalhou?". Pergunta "o que você aprendeu a fazer, com que complexidade e com quais responsabilidades?"

Gabriel Batista - texto da edição original

CAPÍTULO 03

PIA e PTS: instrumentos distintos, competências em diálogo

O Plano Individual de Atendimento (PIA) tem usos definidos pelas normas de cada serviço. Como exemplo delimitado, a Nota Técnica SMADS nº1/2026, do SAICA - Trajetória de Rua e na Rua, organiza objetivos, ações, metas, prazos e responsabilidades com participação da criança ou adolescente, família e rede quando pertinente. Esse modelo não deve ser generalizado automaticamente a todas as modalidades do SUAS.

Na saúde, a publicação do Ministério da Saúde Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular descreve o PTS como uma construção interdisciplinar: compreender a situação, negociar objetivos, repartir responsabilidades e reavaliar o cuidado. A página atual do Ministério sobre autismo exemplifica esse planejamento compartilhado com a pessoa e sua família; não é uma definição exclusiva para TEA.

Eixo	PIA no SUAS	PTS na saúde
Finalidade institucional	Proteção social, direitos, autonomia, vínculos, território.	Cuidado em saúde, funcionalidade, autonomia, clínica ampliada.
Construção	Equipe de referência + usuário/família + rede, conforme o serviço.	Equipe de saúde + pessoa/família + pontos da rede de atenção.

Eixo	PIA no SUAS	PTS na saúde
Plano	Objetivos, ações, metas, prazos, respons abilidades.	Necessidades, objetivos de cuidado, responsabilidades e reavaliação.
O que não são	Não é diagnóstico clínico disfarçado.	Não é formulário fixo nem plano exclusivamente médico.
Competências transversais	Escuta, observação, formulação contextual, documentação, articulação de rede, monitoramento.	Escuta, avaliação, formulação clínica ampliada, documentação, articulação de rede, monitoramento.

Quadro: síntese editorial da Nota Técnica SMADS 1/2026, específica de um SAICA, e do Ministério da Saúde (2008), pp. 40-42. A tabela compara finalidades e processos, sem declarar equivalência entre PIA e PTS.

A existência de instrumentos distintos mostra justamente por que não é necessário escolher entre “Psicologia da saúde” e “Psicologia de humanas”. A mesma formação pode contribuir em políticas diferentes, desde que seu método seja ajustado à finalidade institucional, às normas do serviço e aos limites éticos da profissão.

CAPÍTULO 04

A política pública acontece onde as pessoas estão

Na edição de origem, as fotografias têm função jornalística, não de prova estatística: lembrar que rede, matriciamento, acolhimento e trabalho multiprofissional são atividades concretas, realizadas por equipes em ambientes reais. A identidade profissional se constrói também nesse cotidiano. As fotografias não foram incorporadas a esta prévia.

> Reserva de curadoria: o original apresenta “Registro de atendimento em serviço e trabalho articulado entre profissionais. Acervo do autor.” (p. 5) e “Registro de equipe multiprofissional em contexto de serviço público. Acervo do autor.” (p. 6). Nenhuma fotografia foi importada nesta migração.

Uma fotografia não substitui uma pesquisa. Mas ela pode revelar o que as categorias abstratas escondem: política pública é feita por trabalhadores, relações, equipamentos, documentação, supervisão, decisões e condições materiais de trabalho.

CAPÍTULO 05

São Paulo em números: uma rede fortemente parceirizada

Em notícia de 6 de julho de 2026, a SMADS descreveu 1.387 serviços conveniados, 338 OSCs parceiras e mais de 246 mil vagas na rede parceirizada. Separadamente, informou que a rede direta de referência - CRAS, CREAS e Centros POP - realizou mais de 223 mil atendimentos e alcançou 187 mil pessoas no primeiro semestre. Vagas, atendimentos e pessoas são indicadores distintos, não parcelas para uma soma.

Indicador	Valor e período original
OSCs parceiras	338 - primeiro semestre de 2026
Serviços conveniados	1.387 - primeiro semestre de 2026
Vagas ofertadas	Mais de 246 mil - primeiro semestre de 2026
Atendimentos da rede direta de referência	Mais de 223 mil - primeiro semestre de 2026

Indicador	Valor e período original
Pessoas alcançadas pela rede direta de referência	187 mil - primeiro semestre de 2026

Esses números mudam a pergunta. OSC não é periferia administrativa da política: em São Paulo, é parte central da infraestrutura que sustenta a oferta socioassistencial. Por isso, qualidade da parceria, gestão do trabalho e saúde das equipes não podem ser tratadas como assuntos internos sem relação com o resultado público.

Há OSCs com longa trajetória técnica, equipes qualificadas e serviços complexos. Também há organizações que operam sob forte restrição financeira ou enfrentam problemas de governança. Uma análise responsável precisa rejeitar dois atalhos: demonizar toda organização parceira ou presumir que o poder público deixa de ser responsável pela qualidade do serviço quando assina um termo de colaboração.

Se a rede depende de centenas de OSCs, qual é o sistema de qualidade que acompanha não apenas metas de atendimento e prestação de contas, mas também rotatividade, vacâncias, formação de lideranças, saúde do trabalhador e segurança psicossocial?

Gabriel Batista - texto da edição original

CAPÍTULO 06

O repasse não chega ao trabalhador em linha reta

A Instrução Normativa SMADS nº 2/2024 mostra que o repasse mensal é estruturado por custos diretos e indiretos. Entre os custos diretos estão remuneração de recursos humanos, encargos sociais e trabalhistas, despesas impostas por lei ou convenções coletivas e fundo provisionado. A norma também determina que a remuneração conste no Plano de Trabalho, observe piso profissional e convenções aplicáveis, seja compatível com o mercado e respeite a planilha referencial do serviço (SÃO PAULO, 2024).

- Orçamento público.
- SMADS / Fundo Municipal de Assistência Social.
- Termo de colaboração.
- Organização da Sociedade Civil.
- Recursos humanos e operação.

Fonte: Fluxo simplificado para fins didáticos. A execução real contém regras de planejamento, prestação de contas, remanejamentos e controles específicos. Isso explica por que um salário baixo não pode ser atribuído automaticamente a uma única causa. Pode haver decisão inadequada da organização, parâmetro insuficiente da parceria, convenção coletiva aplicável, desenho de carreira inexistente, combinação desses fatores ou outras variáveis. A investigação responsável começa pela planilha de custos e pelas regras da tipologia, não pela acusação pronta.

A Portaria SMADS nº46 é datada de 30 de março de 2026, embora seu endereço eletrônico mencione 3 de abril. Ela autorizou recomposição excepcional de RH para outubro de 2024 a setembro de 2025 e disciplinou saldos para outubro a dezembro de 2025. A Portaria 128, de 30 de julho de 2026, alterou sua redação, inclusive o prazo de utilização: até 180 dias do recebimento ou o encerramento da parceria, o que ocorrer primeiro. A aplicação depende das condições e dos anexos da norma.

> Houve necessidade administrativa concreta de recompor despesas de recursos humanos nas parcerias. Isso sustenta a existência de pressão financeira sobre esse componente do custeio. Não permite concluir, sozinho, que toda OSC esteja subfinanciada ou que toda remuneração seja inadequada.

CAPÍTULO 07

Saúde e assistência: como ler diferenças de escala

Em maio de 2026, a Secretaria Municipal da Saúde informava orçamento atualizado de aproximadamente R$ 24,60 bilhões. A SMADS informava orçamento atualizado de aproximadamente R$ 2,94 bilhões, dos quais cerca de R$ 2,57 bilhões estavam no Fundo Municipal de Assistência Social (SÃO PAULO, 2026e; 2026f).

Orçamento atualizado informado em maio de 2026	Valor aproximado
Secretaria Municipal da Saúde	R$ 24,60 bilhões
SMADS	R$ 2,94 bilhões
Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 2,57 bilhões

> Os valores são dotações atualizadas, não despesas já pagas, e se referem a políticas com composições e finalidades diferentes. A comparação, sozinha, não demonstra desvalorização, eficiência ou insuficiência da assistência social. É um contexto de escala que precisa ser combinado com demanda, custos, metas e execução.

A discussão relevante para esta edição é: o valor disponível para assistência social consegue acompanhar a complexidade da rede, os reajustes de pessoal, a expansão de demandas e a qualificação das equipes? Responder exige analisar planilhas de custos e execução, e não apenas comparar o tamanho dos dois orçamentos.

A pergunta que os números não respondem sozinhos:

Quanto custa manter uma equipe estável, treinada, supervisionada e protegida contra riscos psicossociais? Sem responder a isso, eficiência pode virar apenas sinônimo de fazer mais com uma equipe cada vez mais cansada.

Gabriel Batista - texto da edição original

CAPÍTULO 08

O que a pesquisa encontra sobre condições de trabalho

Sales e Maciel(2019) analisaram questionários online de 1.100 psicólogos de todas as regiões do Brasil, encontrando dificuldades de remuneração, carga de trabalho e preparação para o contexto socioassistencial. A presença de participantes de várias regiões amplia o alcance geográfico, mas não transforma essa amostra em retrato representativo de toda a categoria em 2026.

Em estudo qualitativo com 12 psicólogas(os) que haviam trabalhado em serviços socioassistenciais terceirizados de um município do interior do Rio Grande do Sul, Brandolt et al. (2021) encontraram precarização atravessando seleção, contratos, carga horária, função, remuneração, educação permanente e encerramento dos vínculos, além de relações baseadas em medo e intimidação. A amostra é pequena e local, portanto deve ser lida como evidência qualitativa, não como estimativa nacional.

Pauli, Traesel e Siqueira (2019), ao entrevistar seis psicólogos temporários com experiência em CREAS, descreveram desgaste, frustrações, adoecimento, falta de valorização da gestão e insegurança quanto à renovação de contrato. Novamente, é um estudo local e qualitativo, útil para compreender mecanismos e experiências, não para medir prevalência.

Amorim e Dalla Vecchia publicaram, no volume 29(2024) de Estudos de Psicologia (Natal), uma revisão crítica com 17 publicações e quatro eixos: características adoecedoras do trabalho, precarização, sofrimento e estratégias de enfrentamento. O registro do periódico informa publicação eletrônica em 10 de novembro de 2025. É uma síntese heterogênea da literatura, sem estimativa única de prevalência nem demonstração de que toda OSC tenha as mesmas condições.

Fonte	Desenho	Contribuição	Limite
Sales e Maciel, 2019	Survey, n = 1.100	Panorama nacional de condições e identidade.	Questionário online; alcance geográfico não garante representatividade; período anterior a 2026.
Brandolt et al., 2021	Qualitativo, n = 12	Terceirização, medo, contrato e remuneração.	Um município; serviços entre 2013-2017; não mede prevalência nacional.

Fonte	Desenho	Contribuição	Limite
Pauli et al., 2019	Qualitativo, n = 6	Desgaste, adoecimento e insegurança.	Seis participantes, um município; vínculos entre 2010-2015.
Amorim e Dalla Vecchia, 2024	Revisão, 17 estudos	Síntese de sofrimento e precarização no SUAS.	Estudos heterogêneos; volume 2024, publicação eletrônica 2025; sem prevalência única.

CAPÍTULO 09

Assédio, prevenção e saúde de quem cuida

O relatório da III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS, publicado pelo CFP em 2025, reúne relatos e debates sobre precarização, assédio moral, equipes reduzidas, salários incompatíveis com responsabilidades técnicas, carga horária, infraestrutura inadequada e ausência de educação permanente. O documento também ressalta que instituições devem promover saúde, dignidade e segurança no trabalho (CFP, 2025).

No campo regulatório, a NR-1 passou a incluir expressamente fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais. A nova redação do capítulo 1.5 entrou em vigor em 26 de maio de 2026, e materiais oficiais citam sobrecarga e assédio entre exemplos de fatores relacionados à organização do trabalho (BRASIL, 2026a).

Vigência normativa, prevenção e aplicação de sanções são questões relacionadas, mas distintas. A discussão sobre a NR-1 também chegou ao STF na ADPF 1316. Para uma decisão fiscal ou jurídica, é necessário consultar as decisões vigentes no processo. O debate judicial não torna assédio, sobrecarga ou gestão inadequada irrelevantes para a prevenção.

Uma organização pode defender direitos humanos em seu projeto institucional e ainda reproduzir relações autoritárias dentro da equipe. Pode oferecer acolhimento ao território e produzir medo nos trabalhadores. Pode promover saúde mental para usuários e tratar sofrimento ocupacional como fraqueza individual. É justamente por isso que valores institucionais precisam ser traduzidos em processos de gestão verificáveis.

- Lideranças precisam ser treinadas em feedback, gestão de conflitos, distribuição de carga, prevenção ao assédio e limites da autoridade administrativa.
- Equipes expostas a alta complexidade precisam de supervisão técnica e espaços de elaboração do trabalho, não apenas palestras eventuais.

- Canais de denúncia precisam ter proteção contra retaliação, fluxo definido, rastreabilidade e devolutiva.
- Rotatividade, afastamentos, vacâncias e clima de equipe devem ser tratados como indicadores de qualidade do serviço.

CAPÍTULO 10

Salário, jornada e proteção: distinguir proposta e direito

O texto inicial do PL 1.551/2026 propõe piso de R$ 4.500 mensais para até 30 horas semanais. Em 17 de outubro de 2026, a ficha da Câmara registra a proposta aguardando designação de relator na Comissão de Saúde, com o PL 2.805/2026apensado. Trata-se de proposta legislativa; o valor não pode ser anunciado como piso nacional criado por esse projeto.

Na mesma consulta, o PL 1.214/2019 permanecia em tramitação no Senado, aguardando despacho, propondo duração de até 30 horas semanais. A situação desses projetos não substitui a análise da legislação e dos instrumentos coletivos aplicáveis a cada vínculo.

Para comparação institucional, assistentes sociais possuem jornada legal de 30 horas desde a Lei nº 12.317/2010. A comparação não pretende opor categorias: mostra que profissionais que frequentemente trabalham lado a lado no SUAS podem estar submetidos a proteções legais diferentes (BRASIL, 2010).

Como referência histórica de negociação no setor saúde paulista, a CCT SinPsi-SP/SindHosp 2025-2026fixou R$ 4.338,84 desde setembro de 2025 e R$ 4.423,05 desde dezembro daquele ano. A cláusula 48 delimitou a vigência de 1º de setembro de 2025 a 31 de agosto de 2026. Os valores não são apresentados aqui como piso atual de outubro, nem como piso nacional ou regra transferível a todos os contratos socioassistenciais. Para contratação ou cálculo atual, é preciso identificar a base de representação, o vínculo e o instrumento vigente.

> Exemplo documental histórico: CCT SinPsi-SP/SindHosp 2025-2026, cláusulas 3ª, 6ª e 48. O instrumento consultado permite jornada inferior com proporcionalidade mediante contrato escrito; não institui jornada nacional de 30 horas para a Psicologia. Projetos de lei e pauta de negociação não são normas vigentes.

Salário é necessário, mas não suficiente. Remuneração digna não corrige sozinha sobrecarga, assédio, falta de supervisão, equipe incompleta ou ausência de carreira. Precarização é um fenômeno multidimensional.

CAPÍTULO 11

Quando o setor de origem apaga competências

Experiência setorial importa. Uma vaga hospitalar pode exigir conhecimento de rotinas hospitalares; um CAPS exige familiaridade com RAPS; um CRAS ou CREAS exige domínio da política socioassistencial. O problema surge quando o setor de origem substitui a análise das competências desenvolvidas.

Um psicólogo que trabalhou no SUAS pode ter desenvolvido competências avançadas em violência, deficiência, vínculos, trabalho com famílias, grupos, crise, autonomia, articulação intersetorial, documentação técnica e leitura de fatores sociais associados ao sofrimento. Essas competências não tornam o profissional automaticamente preparado para qualquer vaga na saúde, mas tampouco desaparecem na mudança de política pública.

Competência	Pergunta de seleção baseada em evidência
Formulação de caso	Consegue integrar história, comportamento, contexto, riscos e recursos sem reduzir a pessoa a uma etiqueta?
Trabalho em rede	Articula saúde, assistência, educação, justiça e território com clareza de responsabilidades?
Documentação	Produz registros e relatórios tecnicamente adequados, objetivos e éticos?
Interdisciplinaridade	Consegue sustentar sua contribuição psicológica sem invadir atribuições de outras profissões?
Gestão de risco	Reconhece situações que exigem escalonamento, encaminhamento ou proteção imediata?
Aprendizagem setorial	Demonstra capacidade de aprender protocolos e fluxos do novo serviço?

> Contratar por competência não significa ignorar experiência específica. Significa evitar que “setor de origem” funcione como atalho para presumir o que o candidato sabe ou não sabe fazer.

CAPÍTULO 12

Dez mudanças possíveis para qualificar serviços e proteger equipes

- 1. Financiamento previsível Revisar planilhas de custo e mecanismos de reajuste com foco explícito em RH, encargos e retenção de profissionais.
- 2. Transparência remuneratória Publicar parâmetros de composição de RH por tipologia e tornar mais legível o que é custo do serviço, salário, encargos e fundo provisionado.
- 3. Formação obrigatória de lideranças Capacitar gerentes e coordenadores em gestão de pessoas, comunicação, conflitos, ética, assédio e riscos psicossociais.
- 4. Supervisão técnica Prever espaços regulares de supervisão e educação permanente para equipes expostas a alta complexidade.
- 5. Canal protegido de denúncia Criar fluxo independente, prazo de resposta, proteção contra retaliação e governança de casos de assédio.
- 6. Indicadores de gente Monitorar rotatividade, vacância, afastamentos, horas extras, tempo de permanência, acidentes e sinais de sobrecarga.
- 7. Fiscalização de qualidade do trabalho Incluir condições de trabalho e estabilidade de equipe na avaliação da parceria, não apenas execução financeira e volume de atendimentos.
- 8. Identidade profissional clara Definir atribuições de psicólogo, serviço social e demais categorias de modo complementar, evitando “técnico genérico” como solução para qualquer demanda.
- 9. Recrutamento por competências Avaliar competências transferíveis entre SUS, SUAS e terceiro setor, sem dispensar formação para especificidades do novo equipamento.
- 10. Participação dos trabalhadores Criar mecanismos regulares para que as equipes influenciem melhorias de processo, formação e prevenção de riscos.

Não se trata de acrescentar burocracia ornamental. Trata-se de reconhecer que gestão do trabalho é parte da tecnologia de cuidado. Uma equipe adoecida, instável ou amedrontada não é um problema “de RH” separado da qualidade assistencial.

CAPÍTULO 13

O que a edição consegue sustentar e até onde

Afirmação	Base documental do original	Limite de interpretação
Psicologia é reconhecida como profissão de saúde.	Resolução CNS nº 287/1998.	PDF oficial conferido; reconhecimento de saúde não torna toda atuação psicológica uma atividade sanitária.
A rede socioassistencial paulistana depende fortemente de OSCs.	338 OSCs e 1.387 serviços conveniados no balanço do primeiro semestre de 2026.	Balanço publicado em 6/7/2026; rede parceirizada diferente dos indicadores de atendimento da rede direta.
RH é componente estruturado do custeio das parcerias.	IN nº 02/SMADS/2024 e Portarias nº 46/2026e nº 128/2026.	Arts. 102-103 e 149 da IN 2/2024 e portarias conferidos; regra de custeio não comprova insuficiência individual.
Há evidências de precarização e sofrimento no trabalho do SUAS.	CFP 2025, estudos de 2019 e 2021, revisão de 2024.	Amostras/desenhos/períodos diferentes; relatos e resultados não medem prevalência de todo o SUAS.
Riscos psicossociais ganharam centralidade regulatória.	NR-1 atualizada e materiais oficiais do MTE; decisão do STF citada na edição.	Vigência normativa e relevância preventiva verificadas no MTE; estado atual das sanções judiciais não foi confirmado.
Psicologia ainda busca piso e jornada nacional.	PL nº 1.551/2026e PL nº 1.214/2019 em tramitação.	Fichas e texto inicial conferidos em 17/10/2026; projetos em tramitação, sem criar direito por si.

O objetivo de uma apreciação crítica não é transformar correlação em prova ou opinião em estatística. É organizar evidências suficientes para formular perguntas melhores. Neste caso, as fontes permitem sustentar que identidade profissional, financiamento, gestão do trabalho e saúde ocupacional são dimensões inseparáveis da qualidade da proteção social.

CAPÍTULO 14

Quem cuida de quem cuida?

A resposta não pode ser apenas “o próprio profissional”. Autocuidado não corrige subfinanciamento. Resiliência não substitui equipe suficiente. Uma palestra não corrige assédio. Supervisão não compensa indefinidamente uma organização do trabalho adoecedora. E vocação não é política salarial.

Também seria simplista responsabilizar apenas as OSCs. Em uma rede baseada em termos de colaboração, poder público e organização parceira compartilham responsabilidades diferentes, mas conectadas. O município define parâmetros, regula, financia e fiscaliza. A OSC administra, contrata, lidera e executa. O trabalhador materializa a política na relação cotidiana com o usuário.

A Psicologia precisa fazer sua parte. Defender identidade profissional não significa transformar o SUAS em extensão da clínica, disputar território com o Serviço Social ou reivindicar privilégio. Significa conseguir explicar o que a formação psicológica acrescenta à proteção social e sustentar essa contribuição com método, ética e trabalho interdisciplinar. O sujeito é biopsicossocial antes de qualquer organograma.

Não deixa de ter corpo quando entra no SUAS. Não deixa de ter história social quando entra no SUS. Não abandona vínculos, cognição, comportamento, cultura, renda ou território na porta de nenhum equipamento. As políticas precisam de fronteiras administrativas; o cuidado precisa de pontes técnicas.

Talvez o próximo passo para amadurecer a relação entre Estado, terceiro setor e Psicologia seja mudar a pergunta. Não apenas quantos profissionais conseguimos colocar na ponta, mas que condições oferecemos para que profissionais qualificados desejem permanecer nela, aprender nela e cuidar bem durante anos.

> Uma política pública que depende de trabalhadores qualificados precisa tratar o trabalho como parte do cuidado. Valorizar a Psicologia no SUAS não é afastá-la das Humanidades nem transformá-la em clínica: é reconhecer a capacidade de compreender pessoas em contextos complexos, com responsabilidade técnica e em diálogo com outras profissões.

CAPÍTULO 15

Nota editorial, ética e recorte documental

Esta é uma apreciação crítica e educativa. Não substitui parecer jurídico, auditoria de parceria, fiscalização trabalhista ou análise individual de condições de trabalho. Não atribui irregularidades a nenhuma OSC específica. As fotografias das páginas 5-6 do original não foram incorporadas. A fonte tem corte em 26 de agosto de 2026; a adaptação registra conferências documentais até 17 de outubro de 2026, preservando os períodos dos dados. O estado atual das sanções discutidas no STF não foi confirmado nesta conferência.

FONTES PARA APROFUNDAR

Referências da edição.

AMORIM, Noelle Lopes; DALLA VECCHIA, Marcelo. Saúde Mental do Trabalhador do Sistema Único de Assistência Social: revisão crítica da literatura. Estudos de Psicologia (Natal), v. 29, e242906, 2024. Publicação eletrônica 10 nov. 2025. DOI 10.69909/1678-4669.20240006.

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?lng=pt&nrm=iso&pid=S1413-294X2024000100801&script=sci_abstract

BRANDOLT, Catheline Rubim et al. Condições de trabalho de psicólogas(os) resultantes do processo de terceirização na assistência social. Psicologia & Sociedade, v. 33, e229301, 2021. DOI 10.1590/1807-0310/2021v33229301.

https://www.scielo.br/j/psoc/a/4nZ73JHvTdy8y5KgXYyCqsD/?lang=pt

BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 1.551/2026. Institui piso salarial nacional da categoria.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2612948

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução 287, de 8 de outubro de 1998.

https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/1998/resolucao-no-287.pdf

BRASIL. Lei 12.317, de 26 de agosto de 2010. Duração do trabalho do assistente social.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12317.htm

FERREIRA, Stela da Silva. NOB-RH/SUAS: anotada e comentada. Brasília: MDS/SNAS, 2011.

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2022/nob-rh_suas_anotada_comentada.pdf

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular. 2. ed. Brasília: MS, 2008.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_equipe_projeto_2ed.pdf

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR-1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Redação vigente desde 26/5/2026.

https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-1

BRASIL. Senado Federal. PL 1.214/2019. Duração do trabalho do psicólogo.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/175233

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 1316. Processo 0169281-54.2026.1.00.0000. Relator: Min. André Mendonça.

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7550472

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Relatório da III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS: o trabalho da Psicologia na efetivação dos direitos socioassistenciais. Brasília: CFP, 2025.

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2025/06/relatorio_mostra_suas_web_2.pdf

PAULI, Cassiele Gomes; TRAESEL, Elisete Soares; SIQUEIRA, Aline Cardoso. A precarização do trabalho dos psicólogos temporários no CREAS. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 39, e188301, 2019. DOI 10.1590/1982-3703003188301.

https://www.scielo.br/j/pcp/a/9xFHbVV7N6DrKXcDHZT9GGd/?lang=pt

SALES, Allana Ribeiro Porto; MACIEL, Regina Heloisa. A atuação do psicólogo na assistência social brasileira. Temas em Psicologia, v. 27, n. 1, p. 233-247, 2019. DOI 10.9788/TP2019.1-17.

https://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v27n1/v27n1a17.pdf

SÃO PAULO (Município). SMADS. Instrução Normativa 2, de 15 de março de 2024. Parcerias socioassistenciais.

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-2-de-15-de-marco-de-2024

SÃO PAULO (Município). SMADS. Nota Técnica 1, de 17 de julho de 2026. SAICA - Trajetória de Rua e na Rua.

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/nota-tecnica-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-1-de-17-de-julho-de-2026/consolidado

SÃO PAULO (Município). SMADS. Balanço semestral da rede socioassistencial. 6 jul. 2026.

https://prefeitura.sp.gov.br/web/popruasp/w/balan%C3%A7o-semestral-da-rede-socioassistencial-saiba-os-principais-resultados-da-pasta-na-metade-do-ano

SÃO PAULO (Município). SMADS. Portaria 46, de 30 de março de 2026, com alterações.

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/portaria-46-de-3-de-abril-de-2026

SÃO PAULO (Município). SMADS. Portaria 128, de 30 de julho de 2026. Altera Portaria 46/2026.

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/portaria-secretaria-municipal-de-assistencia-e-desenvolvimento-social-smads-128-de-30-de-julho-de-2026

SÃO PAULO (Município). SMADS. Ações e Programas: orçamento 2026. Atualização maio/2026.

https://smartsampa.prefeitura.sp.gov.br/web/assistencia_social/w/acesso_a_informacao/178373

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal da Saúde. Ações e Programas: orçamento 2026. Atualização 5/5/2026.

https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/acesso_a_informacao/acoes-e-programas

SINPSI-SP; SINDHOSP. Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2026. Cláusulas 3ª, 6ª e 48.

https://sinpsi.org/wp-content/uploads/2025/10/CCT-PSICOLOGOS-2025-2026-SINDHOSP.pdf

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Relator autoriza levar discussão sobre NR-1 a fórum da AGU para viabilizar conciliação. 14 out. 2026. Registro histórico da referência 22 da migração.

https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/relator-autoriza-levar-discussao-sobre-nr-1-a-forum-da-agu-para-viabilizar-conciliacao/

BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 1.551/2026: texto inicial no avulso da proposição.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=3130537&filename=Avulso+PL+1551/2026

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Manual de interpretação e aplicação do capítulo 1.5 da NR-1: GRO. 2026.

https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/manuais-e-publicacoes/2026/manual_gro_pgr_da_nr_1.pdf

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Projeto Terapêutico Singular. Página sobre atenção à pessoa com TEA.

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/pts

Continue a conexão.

Abrir esta edição no site da NEXO

Texto e curadoria de Gabriel Alves Batista